

Polyradiculoneuropathie aiguës

Syndrome de Guillain-Barré

présenté: Pr F.SERRADJ

*Faculté de médecine de
Constantine*

2024-2025



Objectifs pédagogiques

- Savoir diagnostiquer un sd de Guillain-Barré.
- Identifier les situations d'urgence.
- Prise en charge précoce et adaptée.

Plan

- Introduction- définition
- Circonstances de survenue
- Profil évolutif
- Diagnostic positif
- Formes cliniques
- Diagnostic différentiel
- Pronostic
- Traitement
- conclusion

Introduction - Définition

- Urgence médicale (atteinte respiratoire , troubles de la déglutition)
- **Polyradiculoneurpathie aigue auto-immune monophasique**, souvent post infectieuse .
- *K/ démyélinisation segmentaire des fibres nerveuses périphériques(racines et troncs nerveux)*
- *Diagnostic essentiellement clinique et ENMG.*

Epidémiologie

- Tous les âges
- toutes les races
- Incidence: 1-2/100 000H/an.

Physiopathologie

- **La 1^{ère} théorie** : immunité cellulaire , les lymphocytes T sensibilisés par la protéine P2 de la myéline attaquent la myéline – détruite macrophages
- **La 2^{ème} théorie** : immunité humorale, des AC anti myéline activent le complément → entraînent la destruction de la myéline – macrophages (anticorps anti-GM1, GM2, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b).

Circonstances de survenue

- Au décours d'un **épisode infectieux 2/3 des patients** , (1 à 3 semaines avant les premiers symptômes) des voies aériennes supérieures ou digestives (*CBJ +++*).
- < 2 à 3% des SGB : contexte **post chirurgical, sérothérapie, vaccination**. (antirabique , grippe+++).

Diagnostic positif

- Repose sur un faisceau d'arguments:

Clinique

ENMG

LCR

Clinique

Nerf périphérique fait de Fibres nerveuses

motrices



Signes moteurs

sensitives



Signes sensitifs

végétatives



Signes végétatifs

Nerf périphérique fait de Fibres nerveuses

motrices

sensitives

végétatives

Signes moteurs

Signes sensitifs

Signes végétatifs

- **Déficit moteur** des 4 membres (commence habituellement aux mbres inf où il prédomine, avec évolution ascendante), intensité variable
- **+ aréflexie** (mbres inf++)
- **Atteinte des nerfs crâniens moteurs** (diplopie faciale, ophtalmoplégie, **T de la déglutition**)
- **Pfs paralysie des muscles respiratoires**

Nerf périphérique fait de Fibres nerveuses

motrices

sensitives

végétatives

Signes moteurs

- **Déficit moteur** des 4 membres (commence habituellement aux mbres inf où il prédomine, avec évolution ascendante), intensité variable
- **+ aréflexie** (mbres inf++)
- **Atteinte des nerfs crâniens moteurs** (diplopie faciale, ophtalmoplégie, **T de la déglutition**)
- **Pfs paralysie des muscles respiratoires**

Signes sensitifs

- **Paresthésies+++ précédant** svt la faiblesse M. a.,
Début: orteils et doigts, progression ascendante, (pieds, mains, lèvres, partie ant de la langue et trigéminales)
- **douleurs**
- **H-pallesthésie, akinésthésie, astéréognosie, hypoesthésie tactile et ataxie prop** (signes tardifs)

Signes végétatifs

Nerf périphérique fait de Fibres nerveuses

motrices

sensitives

végétatives

Signes moteurs

- **Déficit moteur** des 4 membres (commence habituellement aux mbres inf où il prédomine, avec évolution ascendante), intensité variable
- **+ aréflexie** (mbres inf++)
- **Atteinte des nerfs crâniens moteurs** (diplopie faciale, ophtalmoplégie, **T de la déglutition**)
- **Pfs paralysie des muscles respiratoires**

Signes sensitifs

- **Paresthésies+++** précédant svt la faiblesse M. a. r. e.
Début: orteils et doigts, progression ascendante, (pieds, mains, lèvres, partie ant de la langue et trégéminales)
- **douleurs**
- **H-pallesthésie**, akinesthésie, astéréognosie, hypoesthésie tactile et ataxie prop (signes tardifs)

Signes végétatifs

- **labilité tensionnelle**, (pfs poussées hypertensives)
- **troubles du rythme cardiaque**
- **troubles vésicosphinctériens**, gastro-intestinaux, de la régulation thermique, de la réactivité vasomotrice cutanée ou de la sudation

Examens complémentaires

LCR

EMG

LCR

ENMG

Signes de démyélinisation:

- Baisse des vitesses de conduction nerveuse,
- Augmentation de la latence de l'onde F (démyélinisation proximale),
- Allongement des latences distales
- Présence de blocs de conduction sur les troncs nerveux, en dehors des zones de compression habituelles

+/- signes de perte axonale associée:

Abaissement des PA moteurs et sensitifs (valeur pc)

Formes axonales motrices pures possibles (CBJ)

LCR

dissociation albuminocytologique:

- **h+protéinorachie** > 0,45 g/L,
(pfs >10 g/L),
- **sans réaction cellulaire**(<10)

: 15^{ème} j

EMG

Signes de démyélinisation:

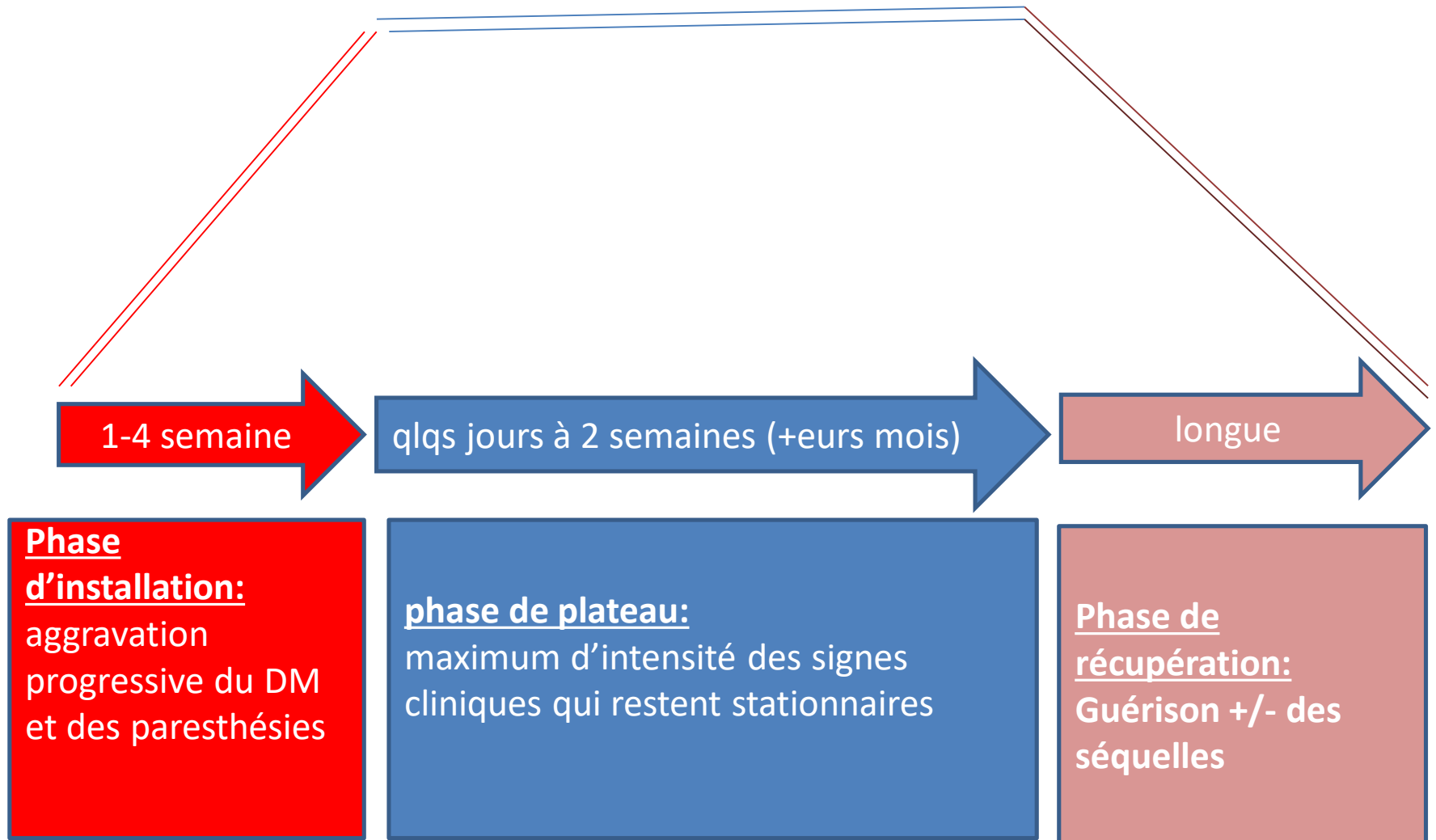
- baisse des vitesses de conduction nerveuse,
- augmentation de la latence de l'onde F (démyélinisation proximale),
- allongement des latences distales
- présence de blocs de conduction sur les troncs nerveux, en dehors des zones de compression habituelles

+/- signes de perte axonale associée:

abaissement des PA moteurs et sensitifs (valeur pc)

Formes axonales pures possibles

Profil évolutif



Formes cliniques

Forme typique:

- **paralysie** d'installation rapide des 4 mbres (tetraparesie ou plegie) + **ou svt (-) des ROT**
(+/- atteinte des nerfs crâniens)
- **paresthésies** des mains et des pieds, d'installation rapide (+/- atteinte proprioceptive)
- +/-atteinte végétative

Forme typique:

- **paralysie** d'installation rapide des 4 mbres (tetraparesie ou plegie) + **ou svt (-) des ROT**
(+/- atteinte des nerfs crâniens)
- **paresthésies** des mains et des pieds, d'installation rapide (+/- atteinte proprioceptive)
- +/-atteinte végétative

Formes motrices pures

absence de
troubles
sensitifs
subjectifs et
objectifs.
(prédominance
des lésions sur
les racines
antérieures),

Forme typique:

- **paralysie** d'installation rapide des 4 mbres (tetraparesie ou plegie) + **ou svt (-) des ROT**
(+/- atteinte des nerfs crâniens)
- **paresthésies** des mains et des pieds, d'installation rapide (+/- atteinte proprioceptive)
- +/-atteinte végétative

Formes motrices pures

absence de
troubles
sensitifs
subjectifs et
objectifs.
(prédominance
des lésions sur
les racines
antérieures),

Formes sensitives pures

- paresthésies +
- ataxie
proprioceptive,
- aréflexie OT
(tbles dys
autonomiques pfs
- peu ou pas de
faiblesse
musculaire
pendant la durée
de la maladie.

Forme typique:

- **paralysie** d'installation rapide des 4 mbres (tetraparesie ou plegie) + **ou svt (-) des ROT** (+/- atteinte des nerfs crâniens)
- **paresthésies** des mains et des pieds, d'installation rapide (+/- atteinte proprioceptive)
- +/-atteinte végétative

Formes motrices pures

absence de troubles sensitifs subjectifs et objectifs.
(prédominance des lésions sur les racines antérieures),

Formes sensitives pures

- paresthésies +
- ataxie proprioceptive,
- aréflexie OT (troubles dysautonomiques pfs)
- peu ou pas de faiblesse musculaire pendant la durée de la maladie.

Pandysautonomie aiguë idiopathique

(rare) fatigue, des vomissements, DL abd, troubles du transit, une hypo TA orthostatique, syncope, impuissance, des troubles de la sudation, de la salivation, des anomalies pupillaires. Les ROT sont diminués ou (-) ds les semaines qui suivent .

Forme typique:

- **paralysie** d'installation rapide des 4 mbres (tetraparesie ou plegie) + **↓ ou svt (-) des ROT** (+/- atteinte des nerfs crâniens)
- **paresthésies** des mains et des pieds, d'installation rapide (+/- atteinte proprioceptive)
- +/- atteinte végétative

Formes motrices pures

absence de troubles sensitifs subjectifs et objectifs.
(prédominance des lésions sur les racines antérieures),

Formes sensitives pures

- Paresthésies +
- Ataxie proprioceptive,
- aréflexie OT (troubles dysautonomiques pfs)
- peu ou pas de faiblesse musculaire pendant la durée de la maladie.

Pandysautonomie aiguë idiopathique

(rare) fatigue, des vomissements, DL abd, troubles du transit, une h-T orthostatique, syncope impuissance, des troubles de la sudation, de la salivation, des anomalies pupillaires. Les ROT sont diminués ou (-) ds les semaines qui suivent .

Syndrome de Miller-Fisher

triade :

- 1- Ophtalmoplégie,
 - 2- Ataxie,
 - 3- Aréflexie OT
- (Pfs évolution vers un SGB, avec un déficit moteur généralisé et une paralysie des muscles respiratoires.

Diagnostic différentiel

Forme typique:

- **Paralysie** d'installation rapide des 4 mbres + **ROT (-)** ou **(+/- att des nerfs crâniens)**
- **Paresthésies** des mains et des pieds, d'installation rapide (+/- atteinte proprioceptive)
- +/-atteinte végétative

DGC différentiel

Myélopathies

(compression, ramollissement, myélite)

- Signes pyramidaux
- Niveau sensitif médullaire
- IRM médullaire

Les multinévrites des vascularites nécrosantes type PAN

- **Douleur**
- Atteinte axonale.
- Signes extraneurologiques
- Biopsie neuromusculaire +++: vascularite nécrosante

Méningo-radiculo-nevrite infectieuse (Lyme,VIH)

- Hyper proteinorachie
- Réaction cellulaire dans le LCS
- Sérologie

La porphyrie aiguë intermittente:

- ATCD familiaux
- Atteinte motrice pure axonale
- Douleurs abdominales
- Notion d'urines fonçant à la lumière et de prise MDCT: barbiturique+++.

Formes motrices pures

absence de troubles sensitifs subjectifs et objectifs.
(prédominance des lésions sur les racines antérieures),

DGC différentiel

Polymyosite aiguë (myogène)

- **ENMG**
- Enzymes musculaires: élévation importante

Myasthénie (jonction NM)

- Atteinte oculaire
- Fluctuation de la symptomatologie
- Test à la Prostigmine

•Formes paralytiques de poliomyélite antérieure aiguë (corne ant) :

- Asymétrie de l'atteinte
- Contexte fébrile
- ENMG : corne antérieure
- Réaction cellulaire dans le LCR.

Ce diagnostic n'est plus posé que de façon exceptionnelle.



Formes sensibles pures

- Paresthésies +
- Ataxie prpriocéptive,
- Aréflexie OT
- peu ou pas de faiblesse musculaire pendant la durée de la maladie.

DGC différentiel

Le diagnostic de paresthésies progressives isolées ou accompagnées d'un déficit moteur discret ou absent est plus difficile.

Dans ces cas, hospitaliser le patient, le surveiller et pratiquer les examens nécessaires, inorganicité de ces manifestations.

Pronostic

- Patients guérissent +++.
- 3 à 5% des patients décèdent de détresse respiratoire ou de troubles végétatifs.
- Des séquelles s'observent chez 7 à 22 % des patients.

Facteurs de mauvais pronostic

- Age > 50ans.
- Aggravation rapide en moins de 7 jours.
- Importance du déficit moteur au maximum des paralysies.
- Nécessité d'une ventilation mécanique.
- Phase de plateau > 3 semaines.
- Amyotrophie précoce.
- Atteinte axonale +++
- Infection à *Campylobacter jejuni*.

TRAITEMENT

- Traitement symptomatique
- Immunothérapie

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

- Troubles de la déglutition → sonde gastrique.
- Oxygénothérapie nasale et kiné respiratoire, aspirations bronchique, ventilation
- Troubles sphinctériens → sonde urinaire
- Constipation : régime riche en fibres, laxatifs.
- Infection(urinaires, BP) : ATB
- CPC de décubitus → changement de position + matelas anti escarres.
- Prévention des phlébites et des embolies pulmonaires → **héparinothérapie.**
- Kératite/PFP → collyre +pansement occlusif
- Douleur → **antalgiques.**
- **Prévention de l'ulcère de stress.**
- **Soutien psychologique**
- **Rééducation fonctionnelle.**

IMMUNOTHÉRAPIE

❖ Echanges plasmatiques

- - 2 EP formes modérées, 4EP déficits plus sévères: raccourcir la durée de la ventilation mécanique, le temps pour récupérer une marche indépendante

❖ TRT par fortes doses d'Immunoglobulines par voie veineuse

- 0,4 g/kg/j pendant 5 jours .
- Résultats > à ceux des échanges plasmatiques.

Conclusion

- Urgence neurologique survenant souvent dans un contexte post infectieux.
- Pronostic vital et fonctionnel conditionnés par la précocité du diagnostic positif et de la prise en charge adéquate.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION